

אמצעים לנשיאת מטופל

בחלק זה נסקור שניים מהאמצעים השכיחים ביותר לנשיאה והעברה של מטופלים: (1) מיטת האמבולנס (2) כיסא אמבולנס מתקפל.

מיטת האמבולנס

(תמונה 27.4)

דגם: Model 28 Ferno-Flex

משקל המיטה: 30 ק"ג

משקל ההעמסה המקסימלי על מיטת פרנו הישנה 181 ק"ג ו־220 ק"ג על המיטה החדשה. אין לעבור משקל זה. יש להקפיד על הוראות השימוש והוראות הבטיחות (להלן) כדי למנוע התקפלות לא רצונית ולא מבוקרת של המיטה.



תמונה 27.4 מיטת האמבולנס

הוצאת המיטה מן האמבולנס (עם המטופל או בלעדיו)

- משחררים את עַצֵר המיטה הקרוב לדלת האחורית (לצד ימין).
- מושכים את המיטה בעדינות החוצה - על איש הצוות לעמוד לרגלי המיטה ולאחוז בשני צידי המיטה. לא ללחוץ על ידית הקיפול!
- כשרגלי המיטה יצאו וירדו לכיוון הרצפה מניחים רגל על מוט הרוחב התחתון ודוחפים כלפי מטה תוך הרמה קלה של מיטה ומשיכתה החוצה. דרך זו תמנע את קיפול המיטה ונפילתה מהאמבולנס.
- כשהמיטה ניצבת על גלגליה מוודאים שהמפרקים האלכסונים בצידי המיטה ישרים ונעולים, ורק לאחר מכן מתחילים בהוצאה מלאה של המיטה מהאמבולנס.

השכבת המטופל

- השכבת המטופל על המיטה יכולה להתבצע כשהמיטה במצב גבוה או נמוך
- הגבהת המיטה ממצב נמוך תיעשה על ידי שני אנשים לפחות ובשום אופן לא על ידי אדם אחד בלבד
- הגבהת המיטה תיעשה רק לאחר קשירת המטופל באמצעות חגורות הבטיחות וסגירת מעקות הביטחון משני צידי המיטה

הכנסת המיטה עם המטופל לאמבולנס

(תמונה 27.5)

- מצמידים את המיטה לפתח האחורי של האמבולנס כשראש המטופל נכנס ראשון
- מרימים את חלק המיטה הקרוב אל המטפל ולוחצים באמצעות יד ימין את ידית השחרור כלפי מעלה כדי לאפשר קיפול המיטה
- מגלגלים את המיטה לתוך תא המטופל עד שהמיטה תיעצר על ידי העצר
- מקפידים שידי מטופל יהיו על בטנו ולא ייתפסו ברגלי המיטה או בדופן האמבולנס
- מקבעים את המיטה במקומה על ידי עצר המיטה, מוודאים שהמיטה מקובעת



תמונה 27.5 הכנסת מיטת המטופל לתוך האמבולנס

העברת המטופל ממיטה למיטה

- מצמידים את דופן מיטת האמבולנס לדופן המיטה שאליה רוצים להעביר את המטופל
- מקבעים את המיטות כך שלא ינועו בזמן העברה
- משחררים את חגורות הבטיחות
- משחררים את פין אבטחת מגן הצד הקרוב למיטה הצמודה ומורידים את המגן (תמונה 27.6)
- מעבירים את המטופל בעדינות ממיטת האמבולנס (דרושים לפחות שני מטפלים להעברה)
- מחזירים את המיטה לאמבולנס



תמונה 27.6 שחרור פין אבטחת מגן הצד

בדיקה וטיפול של מצב המיטה (על פי הנהלים המקובלים בארגון)

- מחזקים את בורגי המיטה
- בודקים את גלגלי המיטה
- בודקים את חגורות הבטיחות לקרעים ושלמות
- בודקים חופשיות כניסה ויציאה
- יש לבדוק את תקינות המיטה לפני כל משמרת
- אם יש שבר משביתים את המיטה

כיסא אמבולנס מתקפל

(תמונה 27.7)

משקל הכסא: 8.18 ק"ג.

משקל ההעמסה המקסימלי על הכסא: עד 159 ק"ג. אין לעבור משקל זה.



תמונה 27.7 כיסא אמבולנס מתקפל

- חובה לקשור כל מטופל ברצועות לכיסא
- הכיסא נועד לשימושם של שני אנשי צוות לפחות
- ייתכנו מקרים שתידרש עזרה של אדם שלישי ואף רביעי

פתיחת הכיסא - מוודאים בבדיקה פיזית וויזואלית שהכיסא נעול בחלקו האחורי - אחרת המטופל עלול ליפול.

סגירת כיסא - לוחצים על מוט הנעילה. יש לעזוב את מוט הנעילה כשהכיסא מתחיל להתקפל, אחרת האצבעות עלולות להיתפס.

ידיות נשיאה - נמצאות בשני צידי הכיסא בחלקו העליון מאחור ובחלקו התחתון מלפנים לשימוש בזמן נשיאה.

השימוש בכיסא אמבולנס

- מושיבים את המטופל בנוחות על הכיסא
- קושרים את המטופל ברצועות
- מטפל אחד עומד מאחורי המטופל ומקנה את הכיסא על הגלגלים האחוריים. במצב זה אפשר למשוך את הכיסא בלי להרים אותו (תמונה 27.8)



תמונה 27.8 משיכת כיסא אמבולנס על גלגליו האחוריים

נשיאה נכונה

במישור

- ככל האפשר יש להסיע את הכיסא על גלגליו האחוריים
- אם אי אפשר להסיע את הכיסא יש להרימו בויזמנית גם מלפנים וגם מאחור. המטפל שאוחז בידיות התחתונות יכול להיות עם הפנים או הגב אל המטופל (תמונה 27.9)

ירידה במדרגות

- המטפל שאוחז בידיות התחתונות נמצא עם הפנים לכיוון המטופל, מומלץ להיעזר באדם שלישי לתמיכה (תמונה 27.10)
- המטפל שאוחז בידיות התחתונות נמצא עם הפנים לגב המטופל כשפני החולה מופנים קדימה.

חשוב לשמור על הגב!

כאשר מתכופפים להרמת משא - משקל הראש, הידיים, הגוף וכמו כן המשקל שאותו מנסים להרים, מרוכזים באזור ציר המותן - הגב התחתון.

לעומת זאת כשמנסים להרים משא ומכופפים את הברכיים, מקום הציר משתנה, ושרירי הרגליים הם הנושאים במעמסה ולא שרירי הגב.



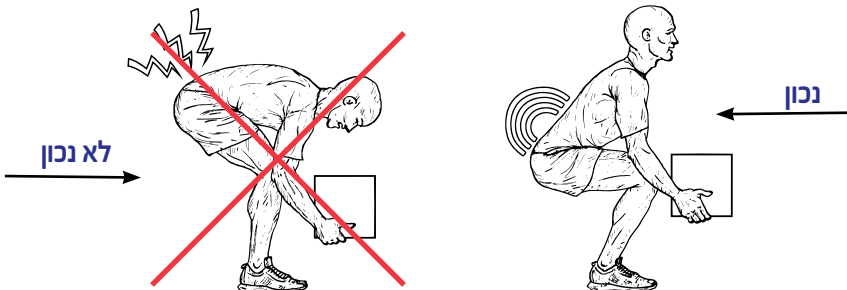
תמונה 27.9 הרמת המטופל על כיסא אמבולנס במישור



תמונה 27.10 הרמת המטופל על כיסא אמבולנס במדרגות

לכן - בכל פעם שמרימים מיטת אמבולנס, כיסא אמבולנס, תיק ואפילו עיפרון יש לזכור את ההבדל בין שתי דרכי ההרמה ולעשות פעולה זו בשימוש בשרירי הרגליים ולא בשרירי הגב (איור 27.1).

ייתכן שבהתחלה לא חשים כאבים בשרירי הגב, אך עם השנים הנזק הולך ונבנה והגב נפגע. עד שמתרגלים לדרך העבודה הנכונה ייתכן שיופיעו כאבים בשרירי הרגליים - אך הם יתחזקו והגב לא ייפגע.



איור 27.1 התכופפות נכונה ולא נכונה